MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION

Cours-QCM orienté annales

PARTIE 1 — Principes de base en Médecine Physique et de Réadaptation

PARTIE 2 — Les situations de handicap et concept de qualité de vie

D’après les cours du Pr F. BENLEBNA — CHU de Mostaganem (2026)
Conçu pour répondre aux QCM / QCS de la banque MedSpark « MPR et handicap »

★ Chaque chapitre se termine par un encart jaune « Ce qui tombe en QCM » : c’est LA partie à maîtriser par cœur. Les encarts verts/rouges donnent les réponses expliquées des QCM types.

PARTIE 1 — PRINCIPES DE BASE EN MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION

1. Définition et concepts clés de la MPR

- La MPR est une spécialité médicale visant l'amélioration du fonctionnement physique et cognitif.
- Rôle du médecin MPR : prévention, diagnostic et traitement des conditions médicales responsables de handicap → améliorer l'autonomie et la qualité de vie.
- La médecine physique : médecine qui utilise, en association avec les traitements médicamenteux, des moyens physiques (courants électriques, ondes infrarouges, ondes courtes…) pour traiter différentes pathologies.
- Rééducation fonctionnelle : diminue les déficiences et les incapacités (intervient quand la fonction est altérée, pour la réduire/récupérer).
- Réadaptation : aide le patient à s'adapter sur le plan fonctionnel et psychique (ensemble de moyens pour l'aider à vivre avec ses incapacités).

★ QCM — Définition de la MPR

n « Spécialité médicale visant l'amélioration du fonctionnement physique et cognitif » → proposition juste.

n La MPR n'est PAS définie par : une population spécifique, ni un organe spécifique.

n Elle est définie par un objectif : LA FONCTION.

n « Son but est de traiter l'organe » → FAUX (but = la fonction/autonomie).

n « Elle prend en charge uniquement des adultes » → FAUX (tous les âges : congénital, enfant, adulte, sujet âgé).

2. Historique (à connaître sommairement)

- 1968 : la spécialité est reconnue sur le plan international par l'OMS.
- 1995 : la « Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles » devient la « Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) ».
- En Algérie : clinique de rééducation chirurgicale créée à Tixeraïne en 1956 ; le Pr Yagoubi Zouhir fut le 1er professeur de Médecine Physique du continent africain. Origine : la « médecine militaire » du 20e siècle.

3. Classification internationale du handicap (CIF / OMS)

Pour bien comprendre les notions de la MPR, on revient à la Classification internationale des handicaps (CIF) :

Notion (CIF 1980)	Définition
Déficience (lésionnel)	Conséquence d'une maladie ou d'un traumatisme : altération du fonctionnement d'un organe ou d'un système, évaluée par rapport au fonctionnement habituel.
Incapacité (fonctionnel)	Conséquences de la déficience sur le fonctionnement de l'individu : limitation de fonctions ou de restriction d'activités.
Handicap / désavantage (social)	Préjudice résultant de la déficience et de l'incapacité, qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal (âge, sexe, facteurs socioculturels). C'est l'expression sociale de la maladie.

Exemple type (traumatisme vertébro-médullaire) :

- Déficiences : déficit sensitivomoteur des 2 membres inférieurs (paraplégie) ; troubles vésicosphinctériens.
- Incapacités : incapacité à marcher ; incapacité d'uriner / rétention urinaire.
- Handicap : désavantage dans le domaine social (impossible de se rendre sur son lieu de travail).

★ QCM — CIF révisée 2001

n Renommée Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé.

n Elle distingue 4 notions : ① Fonctions organiques ② Structures anatomiques ③ Activités et participation ④ Facteurs environnementaux.

n Rééducation → réduit les déficiences ; Réadaptation → aide le patient à s'adapter à ses incapacités / à son comportement.

4. La MPR : un projet d'équipe pluridisciplinaire

La MPR est un projet d'équipe où plusieurs professionnels de santé travaillent ensemble pour atteindre des objectifs précis et personnalisés au patient :

- Récupération des déficiences (motrices, cognitives, vésicosphinctériennes…).
- Réduction des limitations d'activité.
- Meilleure participation socio-professionnelle ou scolaire.

Professionnel	Rôle principal
Médecin MPR (au centre)	Diagnostic médical ; évaluation des déficiences/limitations/restrictions ; décide de la prescription de rééducation (acte médical) ; établit programmes et objectifs ; connaît mécanismes, indications et contre-indications des moyens de rééducation ; évalue les résultats ; coordonne l'équipe.
Kinésithérapeute	Thérapie par le mouvement (amplitudes, renforcement, marche…).
Ergothérapeute	« Thérapie par le travail » : optimise l'autonomie, aides techniques, aménagement du domicile.
Orthophoniste	Troubles de la voix (dysphonie), de l'articulation (dysarthrie), de la parole et du langage (aphasie) ; communication et insertion.
Psychomotricien	Surtout rééducation neurologique de l'enfant ; relaxation dynamique, expression corporelle, jeux, équilibration.
Orthoptiste	Rééducation de la vision / des troubles de l'oculomotricité.
Psychologue	Prise en charge des troubles psychologiques ; obtention de la motivation et de la coopération du patient.
Podologue	Soins et semelles orthopédiques du pied.
Assistante sociale / socio-éducatif	Réinsertion socioprofessionnelle, démarches administratives.

5. Principes généraux en MPR

#	Principe
1	La prescription de rééducation est un acte médical.
2	Elle doit être précédée d'un bilan adapté : objectifs précis, temps défini, orientation sur les besoins réels du patient.
3	Évaluation régulière répétée en cours de traitement : objectiver l'évolution, garantir une démarche de qualité.
4	Orientée vers la meilleure récupération, la meilleure réinsertion, la meilleure qualité de vie, avec la meilleure sécurité et autonomie ; implique la participation active du patient.
6	Doit être continue : dès l'installation des lésions jusqu'à la réinsertion.

#	Principe
7	Doit être coordonnée (dans le temps et l'espace) : domaines médical, éducatif, social, professionnel et économique → travail d'équipe.
8	Doit être scientifique et se soumettre à des règles d'évaluation.
9	S'impliquer dans les instances collectives : faire évoluer la société vers une intégration digne des personnes handicapées.

6. Domaines d'application de la MPR

Très vaste, car la cible est la fonction, à tout âge :

- Orthopédiques : déformations rachidiennes, déviations axiales…
- Traumatologiques : fractures, lésions tendineuses, amputations…
- Rhumatologiques : rhumatismes dégénératifs et inflammatoires.
- Neurologiques : paraplégie, tétraplégie, hémiplégie…
- Gynécologiques : prolapsus génitaux… ; urologiques : troubles vésicosphinctériens.
- Congénitales : paralysie cérébrale (PC), pied bot varus équin (PBVE)…
- Cardiaques et respiratoires ; autres…

7. Le bilan en vue d'une prise en charge en MPR

Chaque acte thérapeutique est précédé d'un bilan clinique et instrumental qui évalue les conséquences fonctionnelles, psychologiques et sociales de la pathologie causale. Principes généraux :

- Évaluation multidisciplinaire (toute l'équipe de MPR).
- Évaluation globale.
- Échelles validées, reproductibles et rapides.
- Évaluation clinique et instrumentale.

Évaluation des déficiences :

- Bilan de la douleur (EVA : échelle visuelle analogique, 0–10 ; siège, type…).
- Bilan cutané (escarre, cicatrice, amyotrophie) ; bilan articulaire ; bilan neuromusculaire.
- Bilan vésicosphinctérien ; bilan orthophonique ; bilan psychologique ; bilan fonctionnel ; bilan général.

Évaluation des limitations d'activité (incapacités) — échelles à connaître :

Échelle	Ce qu'elle mesure / points clés
MIF (Mesure d'Indépendance Fonctionnelle)	Échelle générique : mesure l'autonomie dans 18 activités de la vie quotidienne (soins corporels, alimentation, déplacements, fonctions sphinctériennes, fonctions cognitives). Score final : 18 (min) à 126 (max).
Index de Barthel	Échelle générique d'autonomie dans les AVQ.
FAC (Functional Ambulation Classification)	Échelle spécifique de marche : selon la nécessité d'une aide humaine, d'une canne, possibilité d'emporter/monter les escaliers. Score 0 (impossible de marcher même avec aide) à 5 (déambulation normale).
Enjalbert	Échelle spécifique de préhension chez l'hémiplégique vasculaire : de 0 (préhension nulle) à 6 (préhension surnormale avec pince fine).

Évaluation instrumentale (« explorations fonctionnelles ») : EMG (diagnostic, pronostic, évolution) ; plateformes dynamométriques, barométriques, tapis roulant ; isocinétisme (force à vitesse constante) ; épreuves d'effort cardio-respiratoires (VO2max) ; urodynamique, manométrie rectale, débitmètre.

Évaluation des restrictions de participation (handicap) : souvent confondue avec l'évaluation de l'incapacité ; rejoint la notion de qualité de vie ; doit intégrer l'évaluation de l'environnement du patient ; évaluation multidisciplinaire : médecin MPR, patient, famille, ergothérapeute, assistante sociale, médecin du travail.

★ QCM — Échelles (QCM fréquents)

- MIF : 18 items, score 18 → 126.
- FAC = marche ; Enjalbert = préhension de l'hémiplégique.
- EMG = exploration neuromusculaire (diagnostic, pronostic, évolution).
- Isocinétisme = force à vitesse constante.

8. Prise en charge en MPR : objectifs, principes, moyens

Objectifs thérapeutiques (déterminés selon les déficiences et les incapacités) :

- Lutter contre la douleur, la spasticité…
- Récupérer les amplitudes articulaires ; renforcer les muscles déficients.
- Rééducation de la marche ; améliorer l'autonomie et la qualité de vie.
- Permettre la réinsertion sociale, socio-professionnelle ou scolaire.

Principe de la rééducation	Signification
Précoce	Dès le début de la maladie / lésion.
Continue	Tout au long de la maladie, jusqu'à la réinsertion socioprofessionnelle ou sociale.
Adaptée	À chaque pathologie et à chaque individu, en tenant compte de son état général.
Prudente	Infra-douloureuse ; tenir compte de la fatigabilité du patient.

9. Moyens thérapeutiques utilisés en MPR

Moyen	Contenu / exemples
1. Traitements médicamenteux	Anti-douleurs nociceptives ; anti-douleurs neuropathiques ; infiltrations de corticoïdes, viscosupplémentation ; anti-spastiques classiques ; toxine botulinique +++, blocs moteurs ; autres (ostéoporose, infections, escarres, POAN…) ; médecine complémentaire (acupuncture, mésothérapie, PRP).
2. Moyens physiques	Physiothérapie (chaud, froid) ; parafangothérapie ; ultrasons ; électrothérapie ; massage décontracturant ; massage transverse profond (MTP) ; massage de drainage ; pressothérapie ; ondes de choc.
3. Kinésithérapie	Thérapie par le mouvement : techniques de gain d'amplitude ; renforcement musculaire ; proprioception ; équilibre ; marche ; préhension ; rééducation respiratoire ; réadaptation cardiaque.
4. Balnéothérapie	Soins par l'eau (piscine, cures thermales).
5. Ergothérapie	Thérapie par le travail : optimise l'autonomie ; évaluation analytique des limitations ; évaluation de l'environnement (obstacles) ; techniques de réadaptation et de contournement du handicap ; confection d'aides techniques ; aménagement du domicile.
6. Appareillage orthopédique	Orthèses (attelles, orthèses fonctionnelles, corsets : de repos, de correction, de stabilisation, de suppléance ; semelles et chaussures orthopédiques) ; prothèses ; aides techniques.
7. Orthophonie	Troubles de la voix, de l'articulation, de la parole et du langage.
8. Neuropsychologie	Troubles cognitifs (attention, mémoire, fonctions exécutives…).
9. Psychomotricité	Relaxation dynamique, éducation gestuelle, expression corporelle, jeux rythmiques, équilibration, coordination ; déficiences intellectuelles, troubles de la personnalité ; traumatisés crâniens.
10. Éducation thérapeutique	Apprentissage de la maladie et de son traitement ; conseils d'ergonomie (ex. prévention de la luxation après prothèse totale de hanche, verrouillage du rachis).

Les aides techniques : dispositifs hétérogènes (ex. cannes, fauteuil roulant) ou aménagements de l'environnement qui préviennent ou compensent des déficiences. Elles ne remplacent pas les aides humaines mais y contribuent. L'appareillage implique une prescription et une surveillance médicales, un temps d'application et un entraînement à son usage (rééducation) et à son intégration dans la vie quotidienne.

★ QCM — Moyens thérapeutiques

- n La toxine botulinique est indiquée +++ dans la spasticité.
- n Le massage transverse profond (MTP) fait partie des moyens physiques.
- n L'ergothérapie = « thérapie par le travail » (≠ kinésithérapie = thérapie par le mouvement).
- n Les aides techniques (canne, fauteuil roulant) ne remplacent PAS les aides humaines.
- n Appareillage = prescription médicale + surveillance + entraînement (rééducation).

10. Fiche QCM — Le massage dans les pathologies rhumatismales

Le massage est un moyen physique de la MPR. Chaque manœuvre a un effet précis à connaître par cœur :

Manœuvre de massage	Effet / indication clés
Massage superficiel sédatif (effleurage)	Effet sédatif, calmant ; permet un échauffement des tissus cutanés et sous-cutanés.
Pétrissage	Massage des masses musculaires ; permet une détente musculaire (effet tonifiant si rythme rapide).
Massage transverse profond (MTP)	Massage profond et localisé (technique de Cyriax) ; s'adresse aux pathologies musculo-tendineuses ; principe « no pain, no gain » ; ce n'est pas une manœuvre d'échauffement cutané.
Pincer-rouler	Massage destiné à la prise en charge des cellulalgies (à visée esthétique).

RÉPONSE	QCS type (annale MedSpark) : « A propos du massage dans les pathologies rhumatismales, toutes les propositions sont justes, SAUF : … »
✔ VRAI	B : Le massage superficiel sédatif (effleurage) permet un échauffement des tissus cutanés et sous-cutanés → VRAI.
✔ VRAI	C : Le pétrissage permet une détente musculaire → VRAI.
✔ VRAI	D : Le pincer-rouler est un massage destiné à la prise en charge des cellulalgies → VRAI.
✔ VRAI	E : Le massage transverse profond est un massage plus localisé, il s'adresse aux pathologies musculotendineuses → VRAI.
✘ FAUX	A (la réponse) : « Le massage transverse profond permet un échauffement des tissus cutanés et sous-cutanés » → FAUX : l'échauffement cutané est le rôle de l'effleurage/massage superficiel ; le MTP est profond et localisé.

11. Fiche QCM — La rééducation des pathologies traumatiques

La rééducation (kinésithérapie) après un traumatisme a pour buts fonctionnels :

- Soulager la douleur.
- Récupérer l'amplitude nécessaire des articulations (gain d'amplitude).
- Renforcer les muscles → récupérer une force musculaire normale.
- Retrouver une bonne qualité d'équilibre et de coordination des gestes ; rééducation de la marche, de la proprioception.

RÉPONSE	QCM type (annale MedSpark) : « La rééducation des pathologies traumatiques permet : » (plusieurs réponses) → Réponses : A, C, E.
✔ VRAI	A : De soulager une douleur, de récupérer l'amplitude nécessaire des articulations → JUSTE.
✔ VRAI	C : De retrouver une bonne qualité d'équilibre et de coordination des gestes → JUSTE.
✔ VRAI	E : De récupérer une force musculaire normale → JUSTE.
✘ FAUX	B : La consolidation osseuse → FAUX : c'est un objectif du traitement orthopédique/chirurgical (ostéosynthèse, immobilisation), pas de la rééducation.
✘ FAUX	D : La réduction orthopédique des fractures déplacées → FAUX : geste médico-chirurgical, pas kinésithérapique.

PARTIE 2 — LES SITUATIONS DE HANDICAP ET CONCEPT DE QUALITÉ DE VIE

1. Généralités et chiffres clés

- Pratiquement tout le monde, à un moment de la vie, aura une déficience temporaire ou permanente.
- Plus d'un milliard de personnes vivent avec un handicap → environ 15 % de la population mondiale (2010), contre 10 % en 1970.
- Augmentation de la prévalence : vieillissement des populations + problèmes de santé chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, maladies ostéo-articulaires, troubles de la santé mentale).
- Dans les pays où l'espérance de vie dépasse 70 ans, chaque individu passera en moyenne 8 ans de sa vie avec un handicap.

2. Définitions du handicap

- Définition OMS : « Est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouvent compromises. »
- Nouvelle définition : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé. »

★ QCM — Le handicap est multifactoriel

n Handicap = aspects négatifs de l'interaction entre :

n ① Le problème de santé (maladie, trouble, traumatisme) ;

n ② Les facteurs personnels (ex. les attitudes négatives) ;

n ③ Les facteurs environnementaux (l'inaccessibilité des transports et des bâtiments, des soutiens sociaux limités…).

3. Personne handicapée ≠ personne en situation de handicap

- Personne handicapée : gravité et persistancedans le temps de l'incapacité ; risques majeurs d'obstacles (scolaires, professionnels, sociaux) ; grands besoins de soutien et d'adaptation. Le terme s'emploie dans des contextes spécifiques pour désigner un groupe de personnes.
- Personne en situation de handicap : terme plus large — la situation de handicap peut évoluer au cours de la vie et varier selon les obstacles rencontrés dans l'environnement. C'est la non-réalisation ou réalisation partielle des habitudes de vie d'une personne.
- Exemple type : une personne se déplaçant en béquilles des suites d'une intervention médicale et rencontrant des obstacles pour se déplacer est en situation de handicap sans être handicapée.

4. Étiologies du handicap

Catégorie	Exemples
Lésions cérébrales	Accidents vasculaires cérébraux (AVC), encéphalites, traumatismes crâniens, paralysies cérébrales...
Lésions médullaires	Sclérose en plaques, paraplégies, tétraplégies...
Rhumatismes inflammatoires	Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrites...
Autres	Amputations, arthroses invalidantes, arthrogrypose, troubles vésicosphinctériens, malformations du rachis...

RÉPONSE	QCS type (annale MedSpark) : « Parmi les étiologies du handicap, un seul n'est pas correct, lequel ? » → Réponse : E.
✔ VRAI	A : Les lésions cérébrales → étiologie correcte.
✔ VRAI	B : Les lésions médullaires → étiologie correcte.
✔ VRAI	C : Les rhumatismes inflammatoires → étiologie correcte.
✔ VRAI	D : Les lésions du plexus brachial → étiologie correcte.
✘ FAUX	E (la réponse) : Le syndrome grippal → N'est PAS une étiologie du handicap (affection aiguë bénigne sans séquelles incapacitantes).

5. Pathologies à l'origine du handicap selon le niveau de développement

Contexte	Causes principales
Pays en voie de développement	Ce sont les pathologies infectieuses et infantiles qui sont les principales causes de handicap.
Pays développés	Ce sont des pathologies dues au vieillissement, en particulier les pathologies cardio-neuro-vasculaires, qui sont le plus souvent à l'origine d'une situation de handicap.

القارة العجوز

★ QCM — Piège classique

- Ne pas inverser : infectieuses/infantiles = pays en voie de développement ; vieillissement / cardio-neuro-vasculaires = pays développés.
- « Dans les pays développés, ce sont les pathologies infectieuses et infantiles » → FAUX.
- « Dans les pays en voie de développement, ce sont les pathologies dues au vieillissement (cardio-neuro-vasculaires) » → FAUX.

6. Causes des handicaps en Algérie

Cause	Proportion
Atteintes congénitales ou héréditaires	28,5 %
Séquelles d'accidents ou de blessures	16,7 %
Maladies infectieuses	14,2 %
Effets de la vieillesse	12,5 %
Violences psychologiques ou physiques	7,9 %
Traumatismes	2 %

7. Les types de handicap

- Dans 80 % des cas, le handicap n'est pas visible au premier regard !

On distingue 6 types de handicap :

Type	Ce qu'il touche
Sensoriel	La vue et l'audition ; compromet la perception du monde extérieur.
Moteur	Entrave la mobilité et la motricité.
Psychique	Perturbe les fonctions émotionnelles et comportementales.
Cognitif	Influence la cognition et le traitement de l'information.
Maladie chronique ou invalidante	Limite les capacités fonctionnelles et impacte la qualité de vie à long terme.
Mental ou intellectuel	Affecte l'intellect et les capacités d'apprentissage.

8. Évaluation du handicap (rappel CIF)

- Déficience (lésionnelle) : perte de substance ou altération d'une fonction ou structure psychologique, physiologique ou anatomique.
- Incapacité (fonctionnelle) : réduction de la capacité d'accomplir une action dans les limites considérées comme normales pour un individu.
- Handicap (désavantage social) : résulte d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal (en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels).

Modèle du fonctionnement et du handicap — CIF OMS 2001 : le handicap n'est pas la simple conséquence d'une maladie ou d'un traumatisme : il dépend beaucoup des facteurs environnementaux et personnels. Réduire les handicaps relève donc en partie de la médecine, mais aussi pour une large part de la solidarité sociale.

Modèle	Principe
Modèle intégratif du handicap	L'individu doit s'adapter à la société.
Modèle participatif du handicap	La société s'adapte à l'individu.

Pourquoi évaluer le handicap (initialement et régulièrement) ?

- Établir la réalité des handicaps.
- Mesurer la sévérité.
- Suivre l'évolution.
- Orienter les choix thérapeutiques et mesurer l'efficacité des traitements.
- Déterminer le coût et évaluer l'intérêt des techniques de rééducation et de compensation.
- Apporter des arguments pour les mesures de protection juridique (sauvegarde, curatelle, tutelle) et les indemnisations.

9. Évaluation des déficiences : le tableau à connaître

Déficience	Exemples	Évaluation
Trophique	Examen clinique (peau, amyotrophie…)	Examen clinique
Articulaires	Raideur	Goniométrie
Motrices	Déficit, amyotrophie, spasticité	Testing musculaire manuel ; score d'Ashworth (spasticité)
Sensorielles	Douleur, aphasie, trouble visuel, HLH	EVA (douleur), Échelle Numérique (EN), DOLOPLUS
Sensitives	Hypo/anesthésie, proprioception	Examen de la sensibilité
Psychologiques	Anxiété, dépression	HAD
Cognitives et intellectuelles	Trouble de l'attention, mémoire	MMSE (Mini Mental State Examination), BREF (batterie rapide d'évaluation frontale)
Vésicosphinctériennes et anorectales	Incontinence	Bilan vésico-sphinctérien ; échelle de Ditrovie
Génito-sexuelles	—	Interrogatoire
Viscérales	Trouble de la déglutition, dyspnée, constipation, anémie	NYHA → Dyspnée cardiac insf
Autres	Trouble de l'équilibre	—

★ QCM — Associations échelle / déficience (QCM très fréquent)

- Raideur → goniométrie ; Spasticité → Ashworth ; Force → testing musculaire manuel.
- Douleur → EVA ; Anxiété/dépression → HAD ; Cognition → MMSE / BREF.
- Incontinence → Ditrovie ; Dyspnée/insuffisance cardiaque → NYHA.

10. Évaluation des restrictions de participation

- L'évaluation doit tenir compte du mode de vie propre au sujet : mode de vie habituel, place dans la famille et la société, profession, loisirs, projets → pour personnaliser le projet de vie.
- Elle repose essentiellement sur l'interrogatoire minutieux du patient (type de domicile, profession, loisirs…) et peu sur des échelles (ex. London Handicap Scale).

11. Aides au retour à domicile de la personne handicapée

Catégorie	Contenu
A. Aides humaines	Soins infirmiers ; tierce personne (auxiliaire de vie ou membre de la famille).
B. Aides matérielles — équipements remboursables	Lit médicalisé ; chaise garde-robe ; lève-malade ; matelas anti-escarre ; fauteuil roulant manuel ou électrique ; canne(s) ; déambulateur ; orthèses/prothèses…
B. Aides matérielles — non prises en charge par l'assurance maladie	Barres d'appui ; rehausseur de cuvette de toilettes ; siège pivotant de baignoire ; aide informatisée à la communication ; système de téléalarme…

12. Concept de qualité de vie

- Notion difficile à définir car elle implique une forte part subjective : elle ne saurait être évaluée de façon adéquate qu'en interrogeant directement le patient.
- C'est une affaire de ressenti qui peut varier d'un individu à l'autre (ex. l'échelle de vie).

- Selon l'OMS : la qualité de vie est une combinaison de facteurs psychologiques, physiques, sociaux et matériels pour évaluer le bien-être de l'individu.
- Deux principes fondamentaux : ① Subjectivité : cette notion ne peut être comprise que dans la perspective du patient lui-même ; ② Multi-dimensionnalité : plusieurs dimensions doivent être évaluées.

13. Législation et droits des personnes handicapées

- Monde : Article 25 des Droits de l'Homme (1948) — toute personne a droit à un niveau de vie suffisant assurant sa santé, son bien-être (alimentation, habillement, logement, soins médicaux, services sociaux) ; droit à la sécurité en cas de chômage, maladie, invalidité, veuvage, vieillesse…
- Algérie : environ 2 millions de personnes handicapées (Office National). Handicap moteur le plus important (44 %), puis handicap lié à la compréhension et la communication (32 %), puis handicap visuel (24 %).

Droit (Algérie)	Contenu
Couverture sociale	Prise en charge par la sécurité sociale des soins médicaux.
Transports	Gratuité ou réduction des tarifs.
Logement	30 points supplémentaires pour l'attribution du logement public locatif.
Fiscalité	Exonération de l'impôt sur le revenu global si le revenu mensuel est inférieur à 30 000 DA.
Scolarité	Intégration en milieu scolaire ordinaire / centre spécialisé.
Formation professionnelle	Accès à la formation (plateforme « Mihnati »).
Emploi	Intégration socioprofessionnelle : 1 % des postes de travail consacrés aux personnes en situation de handicap.
Information / loisirs	Accès à l'information, aux services, aux technologies et aux loisirs.
Revenu	Garantie d'un revenu minimum.

Allocation financière (Algérie)	Montant / condition
Handicap à 100 % — adulte	DASS de wilaya : allocation mensuelle de 10 000 DA (adulte > 18 ans, handicap 100 %, sans ressources).
Handicap 100 % — enfant à charge	ADS (Agence du Développement Social) : allocation forfaitaire de solidarité mensuelle de 10 000 DA aux familles sans revenu pour chaque enfant handicapé à 100 %.
Handicap < 100 %	ADS : allocation mensuelle de 3 000 DA (adultes sans ressource titulaires de la carte ; familles sans ressource ayant des enfants handicapés < 100 %).

Dispositifs existants en Algérie : Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l'Homme (CNCPPDH) ; Conseil national des personnes handicapées (depuis 2014) : chargé d'évaluer et de proposer des recommandations ; centres d'enseignement spécialisé ; centres médico-pédagogiques pour l'enfance handicapée ; associations accompagnant les personnes en situation de handicap ; établissements hospitaliers ; ONAAPH (Office National d'Appareillage et d'Accessoires pour Personnes Handicapées).

Problèmes et obstacles en Algérie : lourdeur bureaucratique (dépense publique excessive) ; insuffisance/inadéquation des réponses (prévention, prise en charge précoce, accompagnement tout au long de la vie) ; attitudes négatives des directeurs et enseignants envers les élèves en situation de handicap ; manque de formation des enseignants ; difficultés structurelles (manque de temps, surcharge des cours, manque de matériel adapté et d'accompagnateurs) ; problèmes

d’accessibilité.

QCM corrigés — La Médecine Physique et de Réadaptation

RÉPONSE	QCM type (annale MedSpark) : « La médecine Physique et de Réadaptation : cochez la ou les réponse(s) juste(s) » → Réponses : A, C, D.
✔ VRAI	A : Est une spécialité médicale visant l'amélioration du fonctionnement physique et cognitif → JUSTE.
✔ VRAI	C : Elle est définie par un objectif qui est la fonction → JUSTE.
✔ VRAI	D : Il s'agit d'une spécialité qui n'est pas déterminée par une population spécifique ou un organe spécifique → JUSTE.
✘ FAUX	B : Son but est de traiter l'organe → FAUX (but = la fonction, pas l'organe).
✘ FAUX	E : C'est une spécialité qui prend en charge uniquement des adultes → FAUX (tous âges, dès le nouveau-né).

QCM corrigés — Le Handicap

RÉPONSE	QCM type (annale MedSpark) : « Le Handicap : cochez la ou les réponses justes » → Réponses : A, B, C.
✔ VRAI	A : Dans 80 % des cas, le handicap n'est pas visible au premier regard → JUSTE.
✔ VRAI	B : Dans les pays en voie de développement, ce sont les pathologies infectieuses et infantiles qui sont les principales causes de handicap → JUSTE.
✔ VRAI	C : Dans les pays développés, ce sont des pathologies dues au vieillissement, en particulier cardio-neuro-vasculaires, à l'origine d'une situation de handicap → JUSTE.
✘ FAUX	D : Dans les pays développés, pathologies infectieuses et infantiles → FAUX (c'est l'inverse).
✘ FAUX	E : Dans les pays en voie de développement, pathologies du vieillissement cardio-neuro-vasculaires → FAUX (c'est l'inverse).

RÉCAPITULATIF EXPRESS — À maîtriser la veille de l'examen

[1] MPR = spécialité médicale → fonctionnement physique et cognitif ; définie par LA FONCTION, ni population ni organe.

[2] Rééducation = réduit les déficiences/incapacités ; Réadaptation = aide à s'adapter.

[3] CIF : Déficience (organe) → Incapacité (individu) → Handicap (société). Révisée 2001 : 4 notions dont facteurs environnementaux.

[4] Prescription de rééducation = acte médical ; rééducation précoce, continue, adaptée, prudente.

[5] MIF : 18 items, 18–126 ; FAC = marche ; Enjalbert = préhension hémiplégique ; Ashworth = spasticité ; EVA = douleur ; HAD = anxiété/dépression ; MMSE/BREF = cognition ; Ditrovie = sphincters ; NYHA = cœur.

[6] Effleurage = échauffement cutané/sédatif ; Pétrissage = détente musculaire ; MTP = profond, localisé, musculo-tendineux ; Pincer-rouler = cellulalgies.

[7] Rééducation traumatologique = douleur, amplitude, force, équilibre/coordination (PAS consolidation ni réduction).

[8] Handicap = interaction : problème de santé + facteurs personnels + facteurs environnementaux.

[9] 80 % des handicaps invisibles ; PVD = infectieux/infantiles ; développés = vieillissement cardio-neuro-vasculaire.

[10] 6 types : sensoriel, moteur, psychique, cognitif, maladie chronique, mental/intellectuel.

[11] Algérie : ~2 millions PH ; moteur 44 %, communication 32 %, visuel 24 % ; allocations 10 000 DA (100 %) / 3 000 DA (<100 %) ; 1 % des postes ; 30 pts logement ; exonération IRG si < 30 000 DA.

[12] Qualité de vie : subjective + multidimensionnelle, évaluée en interrogeant directement le patient.

Bonne révision ! Vérifiez chaque encart jaune en vous posant la question « comment cette phrase pourrait-elle être retournée en QCM ? ».